HELP_Organi_P09 — Groupe B — Lots 227 à 231 — 20 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 9 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

B-001 — Haute — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 1 › cadre légal › fenêtre « déclarations à Swissmedic » ; Partie 1 › DX.1 (erreur de médication) › lacune catégorie Swissmedic

Contexte : Le cours cite les délais de l'OMéd (15 jours pour les effets et faits graves, 60 jours pour les autres) et écrit qu'aucune catégorie Swissmedic spécifique n'existe pour l'erreur de médication sans effet indésirable.

Question : Selon l'OMéd en vigueur (RS 812.212.21, articles exacts) et la page de pharmacovigilance de Swissmedic (ElViS), une erreur de médication sans effet indésirable doit-elle être déclarée, et sous quelle catégorie ? Donne les délais exacts, le déclarant obligé (médecin, établissement) et l'URL de Swissmedic. Indique aussi le rôle de CIRRNET (Fondation Sécurité des patients Suisse) pour ces erreurs.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-002 — Haute — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › fenêtre « communication après un incident (FMH/ASSM) » ; Partie 2 › DX.3 › 9.d deuxième intention et ligne « enfant ou incapable de discernement »

Contexte : Le cours cite le guide juridique ASSM/FMH, qui renvoie à une brochure de la FMH et de ses partenaires sur la communication après un incident ; cette brochure n'a pas été lue. L'information d'un patient enfant ou incapable de discernement n'est pas traitée.

Question : Quelle est la brochure suisse en vigueur sur la communication avec le patient après un incident médical (FMH, Fondation Sécurité des patients Suisse, autres partenaires) ? Donne le titre exact, l'année, l'URL et les étapes recommandées de l'entretien (excuse, explication, suite). Comment informe-t-on, selon cette brochure et le droit suisse (CC art. 377-378), un enfant ou un patient incapable de discernement et son représentant ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, auteur, année, URL) ; compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-007 — Haute — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 2 › tableau DX.7 ; Partie 3 › DX.6-DX.7 › fenêtres « LTr art. 6 al. 2bis », « retrait temporaire de l'activité », « conditions de reprise », « prélèvements inexpliqués de stupéfiants », 9.c Alternatives et C- Surveillance

Contexte : Le cours décrit la conduite face à un collègue sous l'influence de l'alcool ou de substances (cadre de garde, ReMed, autorité, LPMéd art. 37 et 43). Il écrit qu'aucune limite légale d'alcoolémie en service, aucun test sans consentement, aucun critère validé de détournement de stupéfiants et aucun calendrier de reprise n'ont été trouvés.

Question : En Suisse, existe-t-il une limite d'alcoolémie ou une règle de tolérance zéro pour les soignants en service (LTr, OLT 3, directives SUVA, règlements hospitaliers types) ? Un employeur peut-il exiger un dépistage d'alcool ou de drogues chez un médecin, et à quelles conditions (consentement, base légale) ? Quels indicateurs de détournement de stupéfiants les établissements suisses utilisent-ils (LStup, OCStup, Swissmedic) ? Quelles conditions et quel suivi de reprise du travail sont recommandés (durée, contrôles, fréquence) par la FMH, ReMed ou une autorité cantonale ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, auteur, année, URL) ; compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-008 — Haute — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6-DX.7 › fenêtre « droit d'aviser et secret professionnel »

Contexte : Le cours écrit que le guide juridique ASSM/FMH décrit le droit d'aviser en cas de danger considérable pour la personne, ses proches ou la collectivité, sans décrire son application à un collègue.

Question : Un médecin peut-il ou doit-il signaler à l'autorité cantonale un collègue inapte qui met des patients en danger ? Précise la base légale (CP art. 321 et levée du secret, LPMéd art. 40 et 41, lois sanitaires cantonales, CC art. 314c et 443) et la procédure de levée du secret professionnel. Donne l'édition la plus récente du guide juridique ASSM/FMH et ses différences avec la version citée.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-003 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › fenêtre « art. 22a » ; Partie 3 › DX.6 › piège LPMéd art. 40 et fenêtre « autorité cantonale de surveillance »

Contexte : Le cours écrit que l'art. 22a LPers protège le lanceur d'alerte fédéral, que le médecin d'un hôpital cantonal dépend du droit cantonal non lu, et que l'art. 40 LPMéd vise l'exercice sous propre responsabilité professionnelle.

Question : Quel droit protège en Suisse le médecin salarié d'un hôpital public cantonal ou privé qui signale de bonne foi une faute d'un collègue (lanceur d'alerte) ? Cite les bases cantonales types (au moins Vaud, Genève, Neuchâtel, Berne, Zurich) et le CO art. 321a et 328. L'art. 40 LPMéd (devoirs professionnels) s'applique-t-il au médecin assistant depuis la révision LPMéd ? Donne la version de la LPMéd en vigueur au 22.10.2026 et l'URL Fedlex.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-004 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › audit des lacunes ; Partie 3 › DX.6-DX.7 › fenêtre « ReMed »

Contexte : Le cours cite ReMed (réseau de soutien de la FMH pour médecins) d'après des extraits : réponse en 72 heures, 250 demandes en 2022. Les textes intégraux étaient inaccessibles (erreur 403), et les garanties de confidentialité n'ont pas été lues.

Question : Quelles garanties de confidentialité ReMed (FMH) donne-t-il, et ReMed est-il indépendant de l'employeur et de l'autorité de surveillance ? Décris sa procédure, le délai de réponse et les chiffres les plus récents (rapport annuel 2023, 2024 ou 2025), avec la part des demandes liées à la dépendance et à l'épuisement. Donne les URL officielles.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-005 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6 (épuisement) › fenêtres « Maslach Burnout Inventory (MBI) », « phénomène d'imposteur » et donnée manquante ASMAC/FMH

Contexte : Le cours cite une enquête suisse de 2026 sur le burnout des soignants (« risque élevé », « syndrome de burnout ») sans les seuils du MBI. Les enquêtes de l'ASMAC et de la FMH n'ont pas été lues.

Question : Quelles sont les données suisses les plus récentes sur l'épuisement des médecins (enquêtes ASMAC/VSAO, FMH, Obsan ; année, effectif, prévalence) ? Donne les définitions des trois sous-échelles du MBI et les seuils de classement utilisés dans l'enquête suisse de 2026 citée. Donne une définition référencée du phénomène d'imposteur. Fournis les URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-006 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › épidémiologie ; Partie 3 › DX.7 › fenêtre « justification du rang 7 » et audit des lacunes

Contexte : Le cours écrit que la prévalence suisse de la dépendance et de l'intoxication en service chez les médecins, de l'inconduite sexuelle envers les patients, des fraudes et des procédures disciplinaires n'a pas été trouvée.

Question : Quelles données suisses existent sur ces quatre points : dépendance ou intoxication en service chez les médecins, inconduite sexuelle envers les patients, fraude, procédures disciplinaires (statistiques des autorités cantonales, de la Commission de déontologie FMH ou de MedReg) ? Donne la source, l'année, l'effectif et l'URL. À défaut, donne les données européennes les plus récentes.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-009 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.5 (« deuxième victime ») › signes et lacunes

Contexte : Le cours écrit qu'aucun signe objectif standardisé ni instrument de dépistage de la détresse de la deuxième victime n'a été trouvé.

Question : Quels instruments validés repèrent la détresse de la deuxième victime (par exemple SVEST, version allemande ou française validée) ? Quelles recommandations suisses (Fondation Sécurité des patients Suisse, FMH, hôpitaux universitaires) organisent le soutien par les pairs ? Donne les titres, les années et les URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-010 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.4 (procédure de sécurité) › fenêtres « sign out » et « écart justifié par l'urgence vitale »

Contexte : Le cours cite la liste de contrôle chirurgicale sans détailler le « sign out ». Il écrit qu'aucune règle ne fixe les étapes qu'on peut omettre en urgence vitale.

Question : Quel est le contenu exact du « sign out » de la liste de contrôle de sécurité chirurgicale de l'OMS et de sa version suisse (programme progress! « La sécurité en chirurgie », Fondation Sécurité des patients Suisse) ? Que prévoit cette version suisse en cas d'urgence vitale ? Donne la version la plus récente, l'année et l'URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-011 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_227_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Partie 1 › DX.1 (erreur de médication) › tableau des étapes (préparation) et lacunes

Contexte : Le cours cite le rapport national et un programme vaudois d'amélioration des contrôles. Il ne donne ni la prévalence suisse nationale des erreurs de médication ni de donnée européenne comparable.

Question : Quelle est la fréquence des erreurs de médication à l'hôpital en Suisse (Fondation Sécurité des patients Suisse, programme progress! « La sécurité de la médication », Obsan, études suisses) ? Donne aussi la donnée européenne de référence la plus récente. Quelles recommandations suisses encadrent la préparation et le double contrôle des médicaments ? Donne les années et les URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :

4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-012 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.2 (erreur ou retard diagnostique) › fenêtre « présentation atypique » et D- Pronostic

Contexte : Le cours s'appuie sur une étude bernoise monocentrique (discordance diagnostique, OR de mortalité 2,40). Il n'a trouvé aucune donnée européenne ni aucun essai récent.

Question : Quelles données suisses ou européennes récentes (2022-2026) mesurent la fréquence et les conséquences des erreurs diagnostiques à l'hôpital ou aux urgences ? Existe-t-il une recommandation suisse sur la sécurité diagnostique (Fondation Sécurité des patients Suisse, SSMIG) ? Donne les références et les URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-013 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.8 (harcèlement) et DX.10 (inconduite sexuelle) › fenêtres « Trois niveaux de prévention », « incapable de discernement ou de résistance » et « Constatations utilisables »

Contexte : Le cours cite la LEg et le Code pénal. Il n'a trouvé ni programme national de prévention du harcèlement en milieu de soins, ni donnée européenne, ni conduite médico-légale pour examiner la victime.

Question : Existe-t-il un programme ou une recommandation suisse de prévention du harcèlement sexuel dans les hôpitaux (BFEG, SECO, FMH, ASMAC, H+) ? Quelle conduite médico-légale recommande-t-on en Suisse pour examiner et documenter une victime d'abus sexuel (sociétés de médecine légale, centres LAVI, CHUV/HUG) ? Rappelle la définition du CC art. 16 sur la capacité de discernement. Donne les années et les URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-014 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.9 (fraude) › fenêtre « tribunal arbitral »

Contexte : Le cours décrit le tribunal arbitral cantonal saisi par un assureur pour manquement à l'économicité ou fraude ; les règles de procédure de la LAMal art. 89 n'ont pas été relues.

Question : Que prévoit la LAMal en vigueur au 22.10.2026 (art. 59 sanctions et art. 89 tribunal arbitral) : qui saisit le tribunal, dans quel délai, quelles sanctions possibles (avertissement, restitution, amende, exclusion) ? Cite aussi les articles du CP applicables au faux certificat médical (art. 318) et à l'escroquerie. Donne l'URL Fedlex.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-015 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6 › fenêtre « médecin du personnel et médecine du travail »

Contexte : Le cours écrit que la protection de la maternité d'une collègue soignante n'a pas été lue.

Question : Que prévoit l'Ordonnance sur la protection de la maternité (OProMa, RS 822.111.52) pour une médecin enceinte (gardes de nuit, substances dangereuses, rayonnements, analyse de risque) ? Donne la version en vigueur et l'URL Fedlex.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-016 — Moyenne — LOT 227 · SSP O7.5

Emplacement : LOT_227_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.7 › fenêtre « autres affections qui miment l'intoxication » et tableau glycémie

Contexte : Le cours donne les seuils d'hypoglycémie du diabète traité (≤ 3,9 et < 3,0 mmol/L) et écrit que ces seuils ne couvrent pas le sujet non diabétique. L'état de mal non convulsif et l'hypothermie n'y figurent pas.

Question : Quel seuil définit l'hypoglycémie chez un adulte non diabétique (triade de Whipple ; recommandation européenne ou suisse la plus récente) ? Quelles affections qui miment l'ivresse faut-il écarter avant de conclure à une intoxication (dont l'état de mal non convulsif et l'hypothermie), selon une source européenne ou suisse récente ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-019 — Haute — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Bloc 2 › 9.c Alternatives › ligne « Grossesse »

Contexte : Le cours indique que Valcyte® et Cymevene® sont contre-indiqués pendant la grossesse et l'allaitement et que Bactrim® est contre-indiqué au dernier trimestre. L'imagerie et les autres médicaments en grossesse n'ont pas été trouvés.

Question : Chez une femme enceinte immunosupprimée, quelles prophylaxies et quels traitements des infections opportunistes recommande-t-on (PcP, toxoplasmose, CMV, tuberculose) selon les recommandations EACS les plus récentes et les informations professionnelles suisses ?

Vérifie la contre-indication de Bactrim® au dernier trimestre dans l'IP suisse actuelle. Donne les différences avec la version EACS citée.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-020 — Haute — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_228_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_228_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Partie 1 › DX.2 › fenêtre « Gradient alvéolo-artériel » ; Partie 2 › DX.3 (PcP) › tableaux PaO_2, gradient A-a, β-D-glucane, calendrier de surveillance et critères de guérison

Contexte : Le cours retient pour la PcP une $PaO_2 < 70$ mmHg (EACS) et un gradient A-a > 35 mmHg pour la prednisone adjuvante, et un β-D-glucane ≥ 80 ng/l sur 2 sérums. La fréquence de surveillance sous cotrimoxazole et les critères de guérison n'ont pas été trouvés.

Question : Selon les recommandations EACS les plus récentes (et, hors VIH, ECIL et la SSI), quels seuils de PaO_2 et de gradient A-a déclenchent les corticoïdes adjuvants dans la PcP ? Donne le schéma de prednisone. Quel seuil et quelle unité de β-D-glucane (Fungitell : pg/ml ou ng/l) retient l'EORTC/MSGERC 2019 ? Selon l'IP suisse de Bactrim®, à quelle fréquence contrôle-t-on kaliémie, créatinine et hémogramme sous fortes doses ? Quelle est la durée du traitement, et quels critères fixent la fin du traitement ou la guérison ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, auteur, année, URL) ; compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-022 — Haute — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_228_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.5 (aspergillose) › passage à la biopsie, calendrier de surveillance (bilan avant traitement, suivi radiologique), critères de guérison, mesures environnementales

Contexte : Le cours décrit le bilan avant voriconazole (ECG avec QTc, électrolytes, fonctions rénale et hépatique). Il n'a trouvé ni le critère de biopsie après un LBA non contributif, ni l'intervalle du scanner de contrôle, ni les critères de fin de traitement, ni la recommandation de filtration de l'air.

Question : Selon la recommandation ESCMID/ECMM/ERS la plus récente (et la SSI ou Swissnoso pour la Suisse), quand faut-il biopsier une suspicion d'aspergillose invasive ? À quel intervalle faut-il contrôler le scanner ? Quelle est la durée minimale du traitement et quels critères permettent l'arrêt ? Quelle concentration résiduelle cible du voriconazole faut-il viser (TDM), et quelles adaptations hépatiques donne l'IP suisse de Vfend® ? Swissnoso recommande-t-elle la filtration HEPA pour les patients neutropéniques ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-023 — Haute — LOT 228 · SSP O7.6

Emplacement : LOT_228_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6 (zona) › fenêtres « Varicelle de l'immunodéprimé », « analgésiques », critère du zona disséminé, C- Surveillance, lacunes (isolement)

Contexte : Le cours écrit que le critère chiffré du zona disséminé, les mesures d'isolement (Swissnoso ne publie rien sur le VZV), la spécialité suisse des analgésiques et le calendrier de contrôle rénal sous antiviral n'ont pas été trouvés.

Question : Quelle définition chiffrée du zona disséminé retient-on (nombre de dermatomes, lésions hors dermatome) ? Quelles mesures d'isolement (aérien et contact, durée) recommandent les hôpitaux universitaires suisses ou l'OFSP pour un zona disséminé ou un zona d'immunodéprimé ? Donne, selon l'IP suisse, les doses d'aciclovir IV et de valaciclovir chez l'immunodéprimé avec leur adaptation rénale. Quels analgésiques pour la douleur aiguë et la névralgie post-zostérienne recommande-t-on en Suisse ? Rappelle la recommandation OFSP actuelle sur le vaccin Shingrix® chez l'immunosupprimé.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P09 — 20 questions : B-001, B-002, B-007, B-008, B-003, B-004, B-005, B-006, B-009, B-010, B-011, B-012, B-013, B-014, B-015, B-016, B-019, B-020, B-022, B-023